

一、单项选择题（1~20 题，每题 1 分，计 20 分）

1. B 2. D 3. B 4. C 5. D
6. C 7. C 8. C 9. A 10. D
11. D 12. C 13. A 14. D 15. A
16. C 17. D 18. C 19. A 20. B

二、多项选择题（21 ~30 题，每题 1 分，共计 10 分）

21. ABE
22. BCE
23. AE
24. ABD
25. ABD
26. ABCDE
27. ABCDE
28. ABD
29. ABC
30. ABCDE

三、填空题（31~40 题，每空 0.5 分，共 20 空，计 10 分）

- 31 . 虚则补其母 实则泻其子
32 . 肝之精气(或肝之余气，或肝血)
33 . 阳气过盛化火 邪郁化火 五志过极化火 阴虚火旺
34 . 真热假寒证 真实假虚证
35 . 胸中 手厥阴心包
36 . 督脉 膀胱经
37 . 未病先防 既病防变
38 . 以升为健 脾燥恶湿
39 . 先天之精 后天之精（水谷之精）
40 . 辨证论治

四、简答题（41~46 题，每题 5 分，计 30 分）

41 . 答：阴损及阳是指阴虚到相当程度，病变发展影响到阳的一方，继而形式以阴虚为主的阴阳两虚（2.5 分）；阳损及阴是指阳虚到相当程度，病变发展影响到阴的一方，继而形成以阳虚为主的阴阳两虚（2.5 分）。

42 . 答：精血同源即肝肾同源。肝藏血，肾藏精，肝血和肾精相互资生、相互转化，肾精可化生肝血，肝血可以滋养肾精，故称精血同源（2.5 分）。水火既济又称“心肾相交”。心在五行属火，肾在五行属水。心位居于上肾位居于下。在生理上，心火必须下降于肾，肾水必须上济于心，心肾之间的生理功能才能协调。心肾之间这种关系，称为“水火既济”（2.5 分）。

43 . 答：佐金平木，是滋阴清肝火以治疗肝火犯肺的治法，又称滋肺清肝法，适用于肺阴不足，右降不及的肝火犯肺证（1.5 分）；若肝火亢盛，左升太过，上炎侮肺，耗伤肺阴的肝火犯肺证，当清肝平木为主，兼以滋肺阴以肃降肺气为治（1.5 分）。泻南补北即泻心火滋肾水，又称泻火补水法，适用于肾阴不足、心火偏旺，水火不济，心肾不交证（2 分）

44 . 答：十二经筋是十二经脉之气结、聚、散、络于筋肉关节的体系，其功能活动有赖于经络气血的濡养，并受十二经脉调节，所以也划分为十二个系统，称为“十二经筋”（2.5 分）。十二皮部是十二经脉之气在体表皮肤一定部位的

反映区。十二经脉及其所属络脉，在体表有一定的分布范围，与之相应，全身的皮肤也就划分为十二个部分，称为十二皮部（2.5 分）。

45 . 答：人体中五种形体组织，包括脉、皮肤、肌肉、筋、骨，合称五体。五体与五脏有密切联系，依赖五脏精气血津液的濡养，故你五脏合体。分别为：心在体合脉，肺在体合皮，脾在体合肉，肝在体合筋，肾在体合骨（2.5 分）。汗、涕、泪、涎、唾五种分泌物称之为五液。五液由五脏之精所化生并分属五脏，故称五脏化液。分别为：心在液为汗，肺在液为涕，脾在液为涎，肝在液为泪，肾在液为唾（2.5 分）。

46 . 答：仓廪之官为脾胃的别称，仓廪即粮仓之义。脾胃主受纳、运化水谷，主管饮食物的消化吸收，故称其“仓廪之官”（2.5 分）。决渎之官为三焦的别称。决即疏通之义，渎指水道。三焦为水液运行的通道，三焦通利，则水液运行通畅，故称其“决渎之官”（2.5 分）。

五、论述题（47~49 题，每题 10 分，计 30 分）

47. 答：寒邪与湿邪致病的相同点：① 同伤机体阳气。寒邪与湿邪同属阴邪，侵袭人体后，都具有损伤阳气得特点（1 分）。②都易侵犯人体下部，所谓“清（寒）湿袭虚，病起于下”（1 分）。

寒邪与湿邪致病不同点：①寒邪直接损伤机体阳气，而湿邪易困阻脾阳。寒为阴气盛的表现，侵入后易困遏卫阳，或损伤脏腑阳气，使阳气的温煦、推动、兴奋等作用减弱，表现为一系列寒性症状，如恶寒、脘腹冷痛、下利清谷等；湿邪侵入，多阻遏脏腑的气机升降，尤易困阻脾胃，损伤脾阳，使脾阳不振，运化失职，水湿内停，出现胸脘痞闷、腹部胀满、大便便溏等症。治疗寒邪伤阳，应祛寒温阳；治疗湿邪伤阳，应通过利湿来通阳（2 分）。②寒性凝滞主痛，而湿性重着。寒邪伤人，易使气血凝结阻滞于经脉，导致筋脉、经络、腠理、毛窍的收缩闭塞，阳气不得布散，故出现恶寒，无汗，肢体屈伸不利、脉紧等症。又寒凝气收，血脉拘急，气血运行不畅，不通则痛，故受寒常见头身肢体关节疼痛之症；湿性重着，湿邪犯人，常见头沉如裹、周身困重，四肢酸沉、关节重着等（2 分）。③两邪在致病中，其分泌物和排泄物在形质上不同。寒邪伤阳，使阳气的温煦、推动功能减退，故分泌物和排泄物澄澈清冷，如鼻流清涕、呕吐清水、咳吐稀痰、小便清长、下利清谷等；湿性黏滞秽浊，故分泌物和排泄物多秽浊不清、滞涩不畅（2 分）④ 所致病证的病程长短不同。寒邪为寒冷之气，致病较快，病程较短；湿邪为重浊有质之邪，致病较缓，但病程较长，甚至缠绵难愈（1 分）。⑤ 发病季节有异。冬季多寒病，长夏季节多湿病（1 分）。

48. 答：阴阳失调主要包括阴阳偏胜、阴阳偏衰、阴阳互损、阴阳格拒、阴阳亡失五种类型。

阴阳偏胜：阳胜则热的实热证，阴胜则寒的实寒证，属“邪气盛则实”（2 分）；

阴胜则阳病的实寒兼阳虚证，阳盛则阴病的实热兼阴虚证，属实中夹虚（2 分）。

阴阳偏衰：阴虚则热的虚热证，阳虚则寒的虚寒证，属“精气夺则虚”；阴虚阳亢证和阳虚寒盛证，属于虚中夹实（2 分）。

阴阳互损：属“精气夺则虚”，但虚损的程度较重，多在累及肾阴、肾阳的情况下发生（1 分）。

阴阳格拒：阴盛格阳，属阴寒盛极（1 分）；阳盛格阴，属阳热极盛（1 分）。

阴阳亡失：阴气或阳气突然大量脱失，则为亡阴或亡阳，都属气脱之极虚（1分）。

49. 答：“气为血之帅，血为气之母”，是对气血关系的高度概括。“气为血之帅”，包括气能生血、气能行血、气能摄血（1分）；“血为气之母”，包括血能载气、血能养气（1分）。

气能生血：血的生成，离不开气作为动力。营气和津液，是血液的主要组成部分，它们由脾胃运化的水谷之精所化生。从摄人的饮食物转化为水谷之精，从水谷之精化生营气和津液，从营气和津液生成血液，整个过程都离不开气的运动。因此说气能生血。气旺则化生血液的功能强，气虚则化生血液的功能弱，甚至发生血虚。临床上治疗血虚病证，在补血的同时，每加补气药以提高疗效（2分）。

气能行血：血属阴而外，血的运行，必须依赖于运行不息的气的推动。具体地说，血是依靠心气的推动而流行的。肺气的宣降、敷布，肝气的疏泄、条达，也是保持血行通畅的重要因素。若心肺气虚，推动无力，可引起血瘀；肝失疏泄，气机郁滞，也会引起血瘀。此外，气机的逆乱，升降出入的异常，也常导致血运失常。临床上治疗血行失常，在治血的同时常配伍补气（以行血）、行气（以活血）、降气（以降血）、升提（以升血）等药物，才能获得较好的疗效（2分）。

气能摄血：摄血，是气的固摄作用的具体体现。血循脉道而行，不致逸出脉外，正是依赖于气的固摄作用。如果气虚无力摄血，就会出现各种出血倾向，临床上称为“气不摄血”，治疗时必须配合应用补气之品，以增强气的摄血功能而达到止血目的（2分）。

血能载气：气无形而动，必须附着于有形之血，才能行于脉中而不致散失。当大量出血时，气亦随之逸脱，故大出血的病人每见面色苍白、精神萎顿、汗出不止、全身瘫软等症，即所谓“气随血脱”（1分）。

血能养气：人体各部，内至五脏六腑，外至四肢百骸，无不有赖于血的濡养，才能维持正常的生理功能。机体的组织器官若得不到血的供养，其功能活动也就无法维持，气亦无由化生。故临床上血虚之人，往往兼有气虚（1分）。